

RECEITA MÉDICA

Paciente: Angelo

Data: 18/03/2026 13:00

Médico: Dr(a). fernando

CRM: sfgh

Receita Médica #20

1. ■ DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Exame de Sangue Completo

DESCRIÇÃO:

gh

RESULTADO:

Relatório de Análise de Esfregaço de Sangue Periférico

1. Descrição da Imagem e Qualidade Técnica:

A imagem fornecida é um esfregaço de sangue periférico de boa qualidade técnica, bem corado (coloração tipo Romanowsky, como Giemsa ou Wright's) e adequadamente focado, permitindo uma clara visualização

5. Nível de Urgência:

Alta. A presença de parasitas de malária no esfregaço de sangue, especialmente com a suspeita de Plasmodium falciparum (que pode levar rapidamente a malária grave e fatal), exige avaliação médica e início de tratamento urgentes. A urgência inicial "NORMAL" fornecida no contexto clínico deve ser reclassificada imediatamente.

1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR:

Relatório de Análise de Esfregaço de Sangue Periférico

1. Descrição da Imagem e Qualidade Técnica:

A imagem fornecida é um esfregaço de sangue periférico de boa qualidade técnica, bem corado (coloração tipo Romanowsky, como Giemsa ou Wright's) e adequadamente focado, permitindo uma clara visualização da morfologia das células sanguíneas. A magnificação é apropriada para a identificação de parasitas intraeritrocitários e avaliação das características dos eritrócitos.

2. Achados Principais:

- Eritrócitos: Observa-se uma população de eritrócitos predominantemente hipocrômicos (aumento da palidez central) e microcíticos (tamanho reduzido). Há anisocitose (variação no tamanho) e poiquilocitose (variação na forma), com a presença notável de múltiplos eritrócitos em alvo (codócitos).

- Parasitas Intraeritrocitários: O achado mais significativo é a presença de múltiplos parasitas dentro dos eritrócitos. Estes parasitas são principalmente formas anelares (trofozoítos jovens), pequenos, delicados e de coloração roxa. Alguns podem apresentar pequenas cromatinas ("ponto de diamante"). Em alguns campos, pode haver mais de um parasita por hemácia, embora não seja amplamente dominante nesta imagem específica. Não se observam claramente formas avançadas (esquizontes maduros ou gametócitos maduros) nesta única imagem.

- Leucócitos: Não há leucócitos claramente visíveis no campo apresentado.

- Plaquetas: As plaquetas estão presentes e parecem ter uma contagem adequada, embora uma estimativa precisa requeira a avaliação de múltiplos campos.

1. 3. Diagnóstico Sugerido:

Os achados morfológicos dos eritrócitos (hipocromia, microcitose, eritrócitos em alvo) em conjunto com a presença inequívoca de parasitas intraeritrocitários na forma de anéis são altamente consistentes com Malária.

Considerando a morfologia dos anéis (pequenos, delicados, com cromatina fina), a ausência de hemácias aumentadas ou distorcidas, e a potencial presença de múltiplos anéis por hemácia (mesmo que não proeminente aqui), a espécie mais provável é o *Plasmodium falciparum*. No entanto, a confirmação definitiva da espécie requer a avaliação de mais campos e a identificação de outras fases do ciclo de vida do parasita (trofozoítos mais maduros, esquizontes e gametócitos).

3. 4. Recomendações:

1. *Confirmação e Quantificação: Realizar contagem da parasitemia (percentual de eritrócitos infectados) e buscar ativamente por outras formas do parasita para confirmação da espécie de Plasmodium (se ainda não clara).*

2. *Tratamento Antimalárico: Iniciar imediatamente o tratamento antimalárico apropriado para a espécie identificada e a gravidade clínica do paciente, seguindo os protocolos nacionais e internacionais.*

3. *Avaliação Clínica Abrangente: O paciente deve ser avaliado clinicamente para sinais e sintomas de malária grave, como anemia grave, icterícia, disfunção renal, dificuldade respiratória, alteração do nível de consciência, choque e hipoglicemia.*

4. *Exames Laboratoriais Adicionais:*

* *Hemograma completo: Para avaliar a gravidade da anemia, contagem de leucócitos e plaquetas (trombocitopenia é comum).*

* *Função renal e hepática: Para monitorar possíveis danos orgânicos.*

* *Eletrólitos e glicemia.*

* Gasometria e lactato: Em casos de suspeita de malária grave.

5. Monitoramento: Realizar esfregaços de sangue seriados para monitorar a resposta ao tratamento e a depuração dos parasitas.

5. Nível de Urgência:

Alta. A presença de parasitas de malária no esfregaço de sangue, especialmente com a suspeita de *Plasmodium falciparum* (que pode levar rapidamente a malária grave e fatal), exige avaliação médica e início de tratamento urgentes. A urgência inicial "NORMAL" fornecida no contexto clínico deve ser reclassificada imediatamente.

2. ■ PRESCRIÇÃO MÉDICA

• Conforme orientação médica.**Artemether + Lumefantrine**Apresentação: 20 mg + 120 mg (comprimido)Posologia: 4 comprimidosFrequência: Inicialmente, depois 8 horas após a primeira dose, e então 2 vezes ao dia (a cada 12 horas)Duração: 3 dias (total de 6 doses)Via: OralQuantidade: 24 comprimidosObservações: Tomar com alimentos ou leite para melhor absorção. Monitorar sinais de malária grave e buscar atendimento médico imediato se houver piora.

3. ■ RECOMENDAÇÕES

3. Seguir orientações médicas.

IMPORTANTE: Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

Dr(a). fernando

CRM: sfgh

Documento emitido em 21/03/2026 às 21:54

Este documento é válido em todo território nacional

DoctorIA - Sistema Médico © 2024